

MÓDULO 2

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

(Específicos MFC)

SUMÁRIO

- 1. Guia Estratégico
- 2. MFC — Conceitos e Atributos (Starfield)
- 3. Abordagem Centrada na Pessoa, Família e Comunidade
- 4. Organização do Processo de Trabalho na APS
- 5. Ética Médica, Sigilo, Prontuário e Consentimento
- 6. Biossegurança e Segurança do Paciente
- 7. Calendário Vacinal 2026 (PNI atualizado)
- 8. Saúde da Criança — Puericultura e Triagem Neonatal
- 9. Saúde da Mulher — Pré-natal e Planejamento Reprodutivo
- 10. Rastreamento de Cânceres — Colo Útero (2025) e Mama (2025)
- 11. HAS — Diretriz SBC 2025
- 12. Diabetes Mellitus — Diretriz SBD 2024-2025
- 13. Saúde do Adulto e do Idoso
- 14. Saúde Mental na APS
- 15. Demanda Programada/Espontânea e Visita Domiciliar
- 16. Cuidado Compartilhado e Apoio Matricial
- 17. Grupos Prioritários e Vulneráveis — Políticas Específicas
- 18. Educação em Saúde
- 19. Pegadinhas Clássicas IBAM (25)
- 20. Questões de Revisão Comentadas (18)

1. GUIA ESTRATÉGICO — MÓDULO 2

Área	Questões	Peso	Pontos	Prioridade
SUS/Saúde Coletiva (Módulo 1)	20	2	40	■■■■■■■
Específicos MFC (ESTE módulo)	10	3	30	■■■■■■■■■ — maior peso/questão
Língua Portuguesa	10	1	10	■■■■■

■ ESTRATÉGIA

Cada questão aqui vale 3 pts — errar uma dói mais que errar no SUS.

O IBAM cobra CONCEITOS e DEFINIÇÕES — não casos clínicos complexos.

Foco máximo: atributos Starfield, rastreamentos (mudanças 2025!), calendário vacinal, HAS e DM.

Tema	Frequência IBAM	Novidade 2025
Atributos APS — Starfield (4 essenciais + 3 derivados)	Alta	Não
Rastreamento colo útero — DNA-HPV como 1ª linha	Alta	SIM — crítico
Rastreamento mama — 40 a 74 anos	Alta	SIM — Lei 15.284/2025
HAS — Diretriz SBC 2025 (pré-hipertensão nova)	Alta	SIM
DM — Diretriz SBD 2024-2025 (TOTG-1h)	Alta	SIM
Calendário vacinal — vacina VSR gestante	Alta	SIM
Processo de trabalho APS / acolhimento / demanda	Média-Alta	Não
Saúde da criança — puericultura / 4 testes neonatais	Média-Alta	Não
Saúde mental na APS — o que tratar vs encaminhar	Média	Não
Grupos vulneráveis — políticas	Média	Não

2. MEDICINA DE FAMÍLIA — CONCEITOS E ATRIBUTOS DA APS (Starfield)

2.1 Definição da Especialidade:

A MFC provê atenção continuada, integral e centrada na pessoa, à família e à comunidade. O médico de família cuida de PESSOAS — não de órgãos isolados — em todas as fases da vida.

2.2 Atributos da APS — Barbara Starfield:

Atributo	Tipo	Definição	Pegadinha
Primeiro Contato	ESSENCIAL	APS = porta de entrada PREFERENCIAL do sistema	A prova coloca "qualquer problema" → INCOMPLETO
Longitudinalidade	ESSENCIAL	Vínculo contínuo profissional-paciente ao longo do tempo	Não é "continuidade de tratamento". Inclui pacientes saudáveis
Integralidade	ESSENCIAL	Conjunto articulado: promoção + prevenção + reabilitação	Não é "resolver tudo na APS". É oferecer o conjunto e coordenar
Coordenação do Cuidado	ESSENCIAL	APS organiza o cuidado ao longo dos pontos da rede	A prova coloca "coordenar hospital/UPA" → ERRADO: coordenação é função da APS
Orientação Familiar	DERIVADO	Família como unidade de cuidado — genograma, APGAR familiar	Não obrigatório em toda APS; não existe em todo sistema
Orientação Comunitária	DERIVADO	Conhecer e usar os recursos da comunidade/território, ACS, PSE	Não obrigatório em todos os sistemas
Competência Cultural	DERIVADO	Adaptar cuidado à diversidade étnica, cultural e religiosa	Especialmente para população indígena

■ **MACETE — Atributos**

4 ESSENCIAIS = PLIC: Primeiro contato | Longitudinalidade | Integralidade | Coordenação
3 DERIVADOS: Orientação Familiar | Orientação Comunitária | Competência Cultural
Essenciais = existem em qualquer APS de qualidade. Derivados = qualificam ainda mais.

■ **PEGADINHAS — Atributos**

Longitudinalidade ≠ continuidade de tratamento. Vínculo inclui paciente SAUDÁVEL.
Integralidade ≠ resolver tudo na APS. É oferecer o conjunto e coordenar o restante.
São 4 essenciais — a prova cita 3 omitindo Coordenação ou coloca 5.

3. ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA, FAMÍLIA E COMUNIDADE

3.1 Método SOAP (RCOP — Registro Clínico Orientado por Problemas):

Componente	O que registra
S — Subjetivo	Queixa principal, história da doença, medicamentos em uso, alergias — o que o paciente relata
O — Objetivo	Sinais vitais, exame físico, resultados de exames — o que o profissional observa
A — Avaliação	Hipóteses diagnósticas, diagnósticos, problemas identificados — raciocínio clínico
P — Plano	Conduta: exames, prescrições, orientações, encaminhamentos, retorno

3.2 Ferramentas de Avaliação Familiar:

Ferramenta	Descrição
Genograma	Representação gráfica da família em ≥ 3 gerações. Identifica padrões de doença e dinâmica. ■ = homem, ■ = mulher, X = falecido
Ecomapa	Relações da família com ambiente externo: trabalho, amigos, serviços, comunidade
APGAR Familiar	5 itens (0-2 cada): Adaptação Participação Crescimento (Growth) Afeto Resolução. 0-3=disfunção grave; 4-6=moderada; 7-10=boa função
Ciclo de vida familiar	Estágios: formação → filhos pequenos → adolescentes → ninho vazio → velhice. Crises normativas em cada transição

■ **APGAR Familiar — cobrado pelo IBAM**

A = Adaptação | P = Participação | G = Growth (Crescimento) | A = Afeto | R = Resolução

Pontuação: cada item 0 (nunca), 1 (às vezes), 2 (sempre). Total 0-10.

Mnêmico: "APGAR" — igual ao Apgar do RN mas para a família.

3.3 Modelo Biopsicossocial (Engel, 1977):

Modelo	Foco	Base
Biomédico	Doença como problema biológico isolado	Apenas biologia — ignora psique e contexto social
Biopsicossocial (MFC)	Pessoa em seu contexto: corpo + mente + relações sociais	Bio + Psico + Social — base epistemológica da MFC

4. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS

4.1 Demanda Programada vs Espontânea:

Tipo	Definição	Exemplos	Organização
Programada	Consultas agendadas — condições crônicas	HAS, DM, pré-natal, puericultura, idosos frágeis	60-70% da agenda. Blocos por programa.
Espontânea	Queixas agudas, sem agendamento prévio	Faringite, lombalgia súbita, ansiedade	20-30% da agenda. Acolhimento com classificação de risco
Visita domiciliar	Cuidado no território	Acamados, RN, puérperas, saúde mental	~10% da agenda

4.2 Acolhimento:

Postura ética de ESCUTA QUALIFICADA adotada por TODOS os profissionais em TODOS os momentos. Não é triagem. Não é sala de espera. Implica receber, ouvir, responsabilizar e direcionar.

4.3 Classificação de Risco na APS:

Cor	Prazo	Conduta
Vermelho — Emergência	Imediata	Estabilização + SAMU ou transferência imediata
Laranja — Urgência	≤15 min	Atendimento médico breve; monitorar
Amarelo — Pouco urgente	≤30-60 min	Atendimento na sessão, pode aguardar
Verde — Não urgente	≤120 min	Pode ser agendado ou atendido na sessão
Azul — Eletivo	Agendamento	Orientação e consulta programada

■ PEGADINHAS — Processo de Trabalho

Acolhimento ≠ triagem. Triagem = separar/filtrar. Acolhimento = escuta e responsabilização de TODOS.

"Agenda fechada" não existe no SUS — UBS sempre avalia quem chega com demanda.

Coordenação do cuidado é da APS — não do hospital nem do especialista.

5. ÉTICA MÉDICA, SIGILO, PRONTUÁRIO E CONSENTIMENTO

5.1 Lei 12.842/2013 — Exercício da Medicina:

Ponto	Regra
Atos privativos	Diagnóstico, prescrição, solicitação de exames, alta/internação, atestados, laudos, declaração de óbito
Direção técnica	Chefia imediata de serviço de saúde = privativo do médico
Emergência	Médico NUNCA pode recusar atendimento em emergência — mesmo em consultório particular
Declaração de óbito	Médico assistente emite. SVO: quando não havia médico assistente. IML: suspeita de morte violenta

5.2 Código de Ética Médica — CFM 2.217/2018:

Tema	Regra	Exceção / Pegadinha
Sigilo profissional	Dever de manter sigilo das informações do paciente	Exceção (Art. 73): notificação compulsória, proteção de terceiros, ordem judicial
Notificação compulsória	DEVER do médico — mesmo sem autorização do paciente	NÃO viola sigilo. É exceção prevista em lei.
Consentimento informado	Esclarecer sobre diagnóstico, tratamento, riscos e alternativas	Paciente PODE RECUSAR tratamento — mesmo com risco de vida (autônomo)
Prontuário	Obrigatório. Prazo mínimo: 20 anos. Pertence ao SERVIÇO/INSTITUIÇÃO	A prova diz "pertence ao médico" → ERRADO. Paciente tem direito de acesso.
Telemedicina	Permitida — Resolução CFM 2.314/2022. Exige sigilo e qualidade	A prova generaliza "ilegaldade" → ERRADO

6. BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA DO PACIENTE

6.1 Resíduos de Serviços de Saúde — RDC ANVISA 222/2018:

Grupo	Tipo	Exemplos	Descarte
A	Biológico	Sangue, secreções, curativo, placenta	Saco branco leitoso → autoclave
B	Químico	Medicamentos vencidos, reagentes, mercúrio	Saco laranja ou recipiente específico
C	Radioativo	Radiofármacos	Recipiente com símbolo de radioatividade
D	Comum	Papéis, embalagens do refeitório	Saco preto — lixo comum
E	Perfurocortante	Agulhas, lâminas, bisturis	Caixa amarela rígida (descarpak) — NUNCA no lixo comum

■ **MACETE — RSS**

A=biológico | B=químico | C=radioativo | D=doméstico(comum) | E=perfurocortante(agulha)

Agulha → SEMPRE caixa amarela (E). Nunca na lixeira comum.

6.2 Segurança do Paciente — PNSP (Portaria 529/2013) — 6 Metas:

Meta	Descrição	Na APS
1. Identificar o paciente	≥2 identificadores: nome + data de nascimento	Conferir antes de vacinar ou medicar
2. Comunicação efetiva	Passagem de casos clara — ISBAR	Carta de referência completa; prontuário legível
3. Medicamentos seguros	Alta vigilância: insulina, anticoagulantes, cloreto de potássio	Conferir dose e via antes de injeções na UBS
4. Cirurgia segura	Checklist OMS	Procedimentos menores (sutura) — técnica asséptica
5. Higienizar as mãos	5 momentos da OMS — principal medida	Obrigatório antes e após todo atendimento
6. Reduzir quedas/UP	Escala de Braden; avaliar risco de quedas	Visita domiciliar: ambiente seguro para o idoso

■ **5 Momentos da Higienização das Mãos**

1. ANTES de tocar o paciente | 2. ANTES de procedimento asséptico
3. APÓS risco de exposição a fluidos | 4. APÓS tocar o paciente
5. APÓS tocar superfícies próximas ao paciente

7. CALENDÁRIO VACINAL 2026 — PNI (INSTRUÇÃO NORMATIVA CNV 2026 — ATUALIZADO 30/01/2026)

■ NOVA VACINA 2025-2026 — VSR PARA GESTANTE

Vacina VSR (Vírus Sincicial Respiratório): 1 dose a partir da 28ª semana, em CADA gestação.

Objetivo: proteger o RN contra bronquiolite e pneumonia por VSR — principal causa de hospitalização em lactentes.

Anticorpo Nirsevimabe: alternativa para RN cujas mães não foram vacinadas.

7.1 Calendário da Criança (0-9 anos):

Idade	Vacinas	Observação Crítica
Ao nascer (12-24h)	BCG dose única + HepB 1ª	BCG = dose única, sem reforço. HepB = obrigatória antes da alta.
2 meses	Pentavalente 1ª + VIP 1ª + Rotavírus 1ª + Pneumo10 1ª + MenC 1ª	Rotavírus: JANELA — 1ª dose até 3m7d. Fora da janela = NÃO vacinar.
3 meses	MenC 1ª	Esquema MenC: 3-5-12 meses
4 meses	Pentavalente 2ª + VIP 2ª + Rotavírus 2ª + Pneumo10 2ª	Rotavírus: 2ª e ÚLTIMA dose — janela até 7m29d
5 meses	MenC 2ª	
6 meses	Pentavalente 3ª + VIP 3ª + Influenza	Influenza: anual. 1ª vez (<9 anos): 2 doses com 30d de intervalo
9 meses	Febre Amarela 1ª dose	Antecipar 6-8 meses SOMENTE em área de risco com transmissão ativa
12 meses	Pneumo10 reforço + MenC reforço + SCR + HepA	SCR = Sarampo + Caxumba + Rubéola
15 meses	DTP reforço + VOP reforço + Varicela (SCRV)	DTP reforço. Varicela 2ª
4 anos	DTP 2º reforço + VOP 2º reforço + FA reforço	FA: após 5 anos → dose ÚNICA vitalícia
9 anos	HPV 4v (1 dose) — meninas E meninos	9-14a: dose única. ≥15a: 2 doses. Imunodeprimidos: 3 doses.
COVID-19	Disponível a partir de 6 meses	Esquema conforme recomendação vigente

■ PEGADINHAS — Calendário da Criança

BCG: dose ÚNICA — sem reforço. FA: 1ª dose até 9m, reforço 4a. Após 5 anos: dose única vitalícia.

Rotavírus: JANELA RÍGIDA. 1ª até 3m7d. 2ª até 7m29d. Não vacinar fora do prazo.

HPV: dose única para 9-14 anos (meninas E meninos). ≥15a: 2 doses.

Influenza: anual. Primeira vez (<9a): 2 doses com 30 dias de intervalo.

7.2 Calendário da Gestante:

Vacina	Esquema	Observação
dTpa	1 dose em CADA gestação — 27ª-36ª semana	Proteção do RN contra coqueluche. OBRIGATÓRIA em cada gestação.
Influenza	1 dose em qualquer trimestre — anual	Protege gestante e RN
Hepatite B	3 doses se não vacinada	Se já vacinada: não repetir
COVID-19	Manter esquema atualizado	Segura em todos os trimestres
VSR	1 dose a partir da 28ª semana, em CADA gestação	Nova 2025-2026. Protege RN de VSR.
Febre Amarela	CONTRAINDICADA (vírus vivo)	Excepcionalmente: surto com risco real — avaliar após 1º trimestre
SCR / Varicela	CONTRAINDICADAS (vírus vivos)	Administrar no puerpério imediato se não vacinada

■ **PEGADINHAS — Gestante**

dTpa: em CADA gestação, não apenas na primeira.

Febre Amarela: CONTRAINDICADA. Vírus vivo. A prova tenta colocar como obrigatória → ERRADO.

VSR: nova vacina — não estava em provas anteriores.

7.3 Adulto e Idoso (resumo):

Vacina	Adulto (20-59a)	Idoso (≥60a)
dT	Reforço a cada 10 anos	Reforço a cada 10 anos
dTpa	1 dose em substituição ao dT (convive com bebê/gestante)	1 dose se nunca recebeu
Influenza	Grupos de risco (gestante, prof. saúde, comorbidades)	OBRIGATÓRIA nas campanhas
HepB	3 doses se não vacinado	3 doses se não vacinado
Febre Amarela	1 dose única vitalícia (se área de risco)	Avaliar risco-benefício ≥60a
Pneumo23	Não rotineira para saudável	Acamados/institucionalizados: 2 doses, intervalo 5 anos

8. SAÚDE DA CRIANÇA — PUERICULTURA E TRIAGEM NEONATAL

8.1 Puericultura — Frequência das Consultas:

Faixa Etária	Frequência	Foco
RN 0-28 dias	1ª consulta até 7 dias (ideal 3-5 dias)	Triagem neonatal, icterícia, coto umbilical, vínculo
1-6 meses	Mensalmente	Crescimento, desenvolvimento, vacinação, aleitamento exclusivo
6-12 meses	A cada 2 meses	Introdução alimentar, marcos de desenvolvimento
1-2 anos	A cada 3 meses	Linguagem, marcha, desenvolvimento cognitivo
2-6 anos	A cada 6 meses	Saúde bucal, visão, audição
6-10 anos	Anual	Saúde escolar, crescimento, puberdade

8.2 Triagem Neonatal — Os 4 Testes + 1:

Teste	Prazo Ideal	O que Detecta	Detalhe Crítico
Pezinho	3-5 dias de vida (até 30 dias)	Hipotireoidismo, Falciforme, Fibrose cística, Fenilcetonúria e outras	Pode ir até 30 dias em casos específicos. Ideal: 3-5 dias.
Orelhinha	Antes da alta (até 1 mês)	Perda auditiva congênita	Obrigatória em hospitais com >500 partos/ano. OAE ou PEATE.
Olhinho (Reflexo Vermelho)	Na maternidade ou 1ª consulta	Catarata, glaucoma, retinoblastoma	Reflexo ausente = encaminhar URGENTE à oftalmologia
Coraçãozinho (Oximetria)	24-48h de vida	Cardiopatia congênita crítica	SpO2 ≥95% em MSD e MMII. Diferença ≤3%. Antes da alta.
Linguinha	Antes da alta (complementar)	Anquiloglossia (freio curto)	Protocolo PIBF. Pode ser feito por enfermeiro treinado.

■ Marcos de Desenvolvimento Motor — Referência Rápida

2m: sustenta cabeça em pronação | 4m: rola prono→ supino | 6m: senta com apoio
9m: engatinha, pinça inferior, senta sem apoio | 12m: fica em pé, 1-3 palavras
18m: anda bem, torre de 3 cubos | 24m: corre, frases de 2 palavras

8.3 Aleitamento Materno:

Aspecto	Recomendação Oficial (OMS + MS)
Exclusivo	Apenas leite materno até 6 meses — sem água, chá ou qualquer outro alimento
Complementado	Leite materno + alimentação complementar de 6 meses até 2 anos ou mais
Introdução alimentar	A partir de 6 meses completos — frutas, legumes, cereais, carnes
Contraindicações	HIV materno, HTLV, galactosemia no lactente, drogas ilícitas
HBsAg positivo	NÃO contraindica AM se RN recebeu imunoglobulina + HepB nas primeiras 12h

9. SAÚDE DA MULHER — PRÉ-NATAL E PLANEJAMENTO REPRODUTIVO

9.1 Pré-natal de Risco Habitual (PHPN + Rede Cegonha):

Aspecto	Recomendação MS
Início	Até 12 semanas (1º tri). Ideal: até 120 dias (4 meses).
Nº mínimo de consultas	6 (SUS: PHPN). OMS recomenda ≥8. — 1º tri: 1 2º tri: 2 3º tri: 3
Exames obrigatórios	Tipagem + Rh VDRL Anti-HIV HBsAg Urina I Glicemia jejum Hemograma Toxoplasmose IgM/IgG Rubéola IgG Urocultura
VDRL	1º trimestre + 3º trimestre + no parto
Anti-HIV	1º e 3º trimestres — prevenção transmissão vertical
USG	Idealmente até 14 semanas para datação
Vinculação à maternidade	Gestante deve conhecer a maternidade de referência antes do parto
Alto risco	Idade <16 ou >35a, gemelar, HAS, DM, cardiopatia, pré-eclâmpsia prévia → REFERENCIAR

■ PEGADINHAS — Pré-natal

VDRL: 1º tri + 3º tri + parto. Não é apenas 1 vez.

Anti-HIV: 1º e 3º trimestres — rastreio do binômio.

Rubéola: NÃO vacinar na gestação (vírus vivo). Rastrear; vacinar no puerpério.

HBsAg positivo: NÃO contraindica AM (diferente do HIV).

9.2 Planejamento Reprodutivo — Métodos na APS:

Método	Eficácia Típica	Na APS
Preservativo masculino	~85%	Único que protege contra IST. Sempre recomendar.
COC (pílula combinada)	~91%	1ª linha sem contraindicações. CI: HAS grave, migrânea com aura, tabagismo >35a, trombofilia
Minipílula (progestágeno)	~91%	Puérpera amamentando, CI ao estrogênio.
Injetável trimestral (Depo-Provera)	~94%	Retorno da fertilidade: até 18 meses.
DIU de cobre	>99%	Muito eficaz, não hormonal, reversível. Disponível no SUS. 10 anos.
DIU hormonal (Mirena)	>99%	Reduz fluxo. 5 anos. Pode tratar endometriose.
Laqueadura	>99%	Permanente. Consentimento livre e informado. SUS oferece.
Vasectomia	>99%	Mais simples que laqueadura. SUS oferece.

10. RASTREAMENTO DE CÂNCERES NA APS — DIRETRIZES ATUALIZADAS 2025

■ MUDANÇAS CRÍTICAS 2025 — ALTÍSSIMA PROBABILIDADE DE CAIR NA PROVA

Colo do útero: DNA-HPV SUBSTITUI Papanicolau como método PRIMÁRIO (Portaria SAES/SECTICS 13/2025).
Mama: faixa etária AMPLIADA para 40-74 anos (Lei 15.284/2025).

10.1 Câncer do Colo do Útero — Nova Diretriz 2025:

■ Portaria SAES/SECTICS 13/2025 — MUDANÇA PRINCIPAL

ANTES (até 2024): Papanicolau como método primário, a cada 3 anos, 25-64 anos.
AGORA: DNA-HPV oncogênico = MÉTODO PRIMÁRIO. Papanicolau = exame REFLEXO (secundário).
Transição gradual: onde não há DNA-HPV disponível, Papanicolau continua sendo usado.

Aspecto	Modelo Anterior (Papanicolau)	Modelo Atual 2025 (DNA-HPV)
Método primário	Papanicolau (citologia)	DNA-HPV oncogênico
Faixa etária	25-64 anos	25-64 anos (igual)
Intervalo	A cada 3 anos	A cada 5 anos se negativo
HPV 16 ou 18 positivo	Não se aplicava	→ Colposcopia DIRETA
Outros tipos oncogênicos	Não se aplicava	→ Citologia reflexa na mesma amostra
DNA-HPV negativo	Não se aplicava	→ Repetir em 5 anos
Papanicolau agora	Método primário	Exame reflexo apenas em casos específicos

■ PEGADINHAS — Colo do Útero

Antes de 25 anos: NÃO rastrear (alta regressão espontânea).
Após 64 anos com 2 exames negativos nos últimos 5 anos: ENCERRAR.
HPV 16/18 = colposcopia DIRETA — não esperar citologia.
DNA-HPV negativo = repetir em 5 ANOS (não 3 anos, não 1 ano).

10.2 Câncer de Mama — Lei 15.284/2025:

■ Lei 15.284/2025 + Nota Técnica INCA 626/2025

ANTES (até set/2025): rastreamento bienal para 50-69 anos.
40-49 anos: acesso GARANTIDO à mamografia por DECISÃO COMPARTILHADA médico-paciente.
50-74 anos: rastreamento BIENAL ATIVO (ampliado de 69 para 74 anos).
Acima de 74 anos: decisão INDIVIDUALIZADA.

Faixa Etária	Conduta 2025	Periodicidade
< 40 anos	Apenas com fatores de risco elevado (BRCA, familiar 1º grau)	Individual — pode ser anual com RM
40-49 anos	Acesso garantido por decisão compartilhada (Lei 15.284/2025)	Bienal se optar
50-74 anos	Rastreamento bienal ATIVO (INCA/MS)	A cada 2 anos
≥75 anos	Decisão individualizada	Conforme caso clínico

■ PEGADINHAS — Mama

"Rastreamento para 50 a 69 anos" → DESATUALIZADO. Agora: 50-74 anos (ativo) + 40-49 (decisão compartilhada).

"Mamografia anual" → ERRADO. É bienal (a cada 2 anos).

INCA e Lei 15.284 não são contraditórios: INCA prioriza 50-74; Lei garante ACESSO a partir dos 40.

10.3 Outros Rastreamentos na APS:

Câncer	Recomendação	Quem / Quando
Colorretal	PSOF anual + colonoscopia a cada 10 anos	Homens e mulheres ≥50 anos, risco médio
Próstata	PSA + toque retal — DECISÃO COMPARTILHADA	Homens ≥50a (45a se negro ou familiar 1º grau)
Pulmão	TC de baixa dose — apenas tabagistas alto risco	≥50a, ≥20 maços-ano, fumante atual ou parou <15a
Pele	Exame oportunístico — sem rastreamento formal no SUS	Especialmente fotoexpostos — orientar protetor solar

11. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA — DIRETRIZ SBC 2025

■ ATUALIZAÇÃO CRÍTICA — Diretriz HAS SBC 2025

NOVA CATEGORIA: Pré-hipertensão = PAS 120-139 mmHg E/OU PAD 80-89 mmHg.
PA Normal AGORA: PAS <120 E PAD <80. (Antes: 120/80 era "ótima" — categoria extinta).
1ª diretriz com capítulo sobre HAS NA APS e HAS EM MULHERES.

Classificação SBC 2025	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	Conduta
PA Normal	< 120	< 80	Reavaliar anualmente
Pré-hipertensão (NOVA)	120-139	80-89	MEV. MAPA/MRPA se suspeita de hipertensão mascarada.
HAS Estágio 1	140-159	90-99	Confirmar + MEV ± fármaco conforme risco CV
HAS Estágio 2	160-179	100-109	MEV + tratamento farmacológico
HAS Estágio 3	≥180	≥110	Tratamento imediato
Urgência hipertensiva	≥180/120 SEM lesão órgão-alvo		Reduzir PA em horas. Medicação oral.
Emergência hipertensiva	≥180/120 COM lesão órgão-alvo		Internação. Reduzir PA em minutos. Via IV.

Aspecto	Detalhe — Diretriz SBC 2025
Diagnóstico	≥140/90 em consultório. ≥2 medidas/consulta, ≥2 consultas em dias diferentes (ou MAPA/MRPA)
MAPA	Padrão ouro 24h. Identifica avental branco, mascarada, hipertensão noturna
HAS avental branco	Alta no consultório, normal fora (MAPA normal). NÃO é HAS — mas tem risco aumentado
HAS mascarada	Normal no consultório, alta fora (MAPA alterado). É HAS — tratar
Meta geral	< 140/90 mmHg para maioria
Meta alto risco CV	< 130/80 — DCV estabelecida, DM, DRC, risco CV ≥20%
1ª linha farmacológica	IECA ou BRA + BCC (bloqueador canal de cálcio) + Diurético tiazídico — qualquer dos 3
HAS na gestante	CONTRAINDICADOS: IECA e BRA. Usar: metildopa (1ª linha), nifedipino, hidralazina
Mudança estilo de vida	Sódio <2g/dia, dieta DASH, exercício, perda de peso, redução álcool, cessação tabagismo

■ PEGADINHAS — HAS

120/80 = PA Normal. 120-139/80-89 = Pré-hipertensão (nova). ≥140/90 = HAS.
IECA e BRA: CONTRAINDICADOS na gestação. A prova inclui como opção para gestante → ERRADO.
Urgência = sem lesão órgão-alvo. Emergência = COM lesão. A prova confunde.
Diagnóstico: não em uma medida isolada. Requer confirmação.

12. DIABETES MELLITUS — DIRETRIZ SBD 2024-2025

■ ATUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA — Diretriz SBD 2024

NOVO CRITÉRIO: TOTG-1h — glicemia 1 hora após 75g de glicose.

≥155 mg/dL = pré-diabetes. ≥210 mg/dL = diabetes mellitus.

Os critérios tradicionais (GJ, HbA1c, TOTG-2h) permanecem igualmente válidos.

MUDANÇA TERAPÊUTICA SBD 2025: metformina não é mais a 1ª linha universal para todo DM2.

Critério Diagnóstico	Pré-diabetes	Diabetes
Glicemia de jejum (8h)	100-125 mg/dL	≥126 mg/dL
HbA1c	5,7% - 6,4%	≥6,5%
TOTG-2h (75g glicose)	140-199 mg/dL	≥200 mg/dL
TOTG-1h (NOVO SBD 2024)	155-209 mg/dL	≥210 mg/dL
Glicemia casual + sintomas	—	≥200 mg/dL com poliúria/polidipsia/perda de peso

Aspecto Terapêutico	Diretriz SBD 2025
Rastreamento APS	FINDRISC para estratificar risco. GJ em adultos com risco moderado-alto.
Lógica terapêutica	Escolha INDIVIDUALIZADA — não mais metformina universal. Considerar: risco CV, peso, função renal.
Alto/muito alto risco CV	Preferir inibidor SGLT2 (empagliflozina) ou agonista GLP-1 (semaglutida) — com ou sem metformina
Obesidade predominante	Preferir agonista GLP-1 — redução ponderal + controle glicêmico
Sem comorbidades / baixo risco	Metformina ainda é opção válida, acessível e disponível no SUS
Meta HbA1c geral	< 7%. Individualizar: <6,5% jovens; 7-8% idosos frágeis ou com risco de hipoglicemia
Insulina	DM1; HbA1c>9% com sintomas; falha de hipoglicemiantes orais
Pé diabético	Examinar pés em TODA consulta. Monofilamento 10g. Cuidados diários

■ PEGADINHAS — DM

Metformina não é mais universal para todo DM2. Alto risco CV: preferir SGLT2 ou GLP-1.

TOTG-1h: critério NOVO 2024. ≥155 = pré-DM. ≥210 = DM.

DM gestacional: GJ ≥92 mg/dL em qualquer momento, ou TOTG 100g às 24-28 semanas.

13. SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

13.1 Rastreamentos no Adulto — Resumo APS:

Condição	Método	Quem	Periodicidade
HAS	Medição da PA	≥18 anos	≥1 vez/ano. Anual se pré-HT.
DM2	GJ ou HbA1c	≥35a com fatores de risco	A cada 3 anos se normal
Dislipidemia	Perfil lipídico	Homens ≥35a; mulheres ≥45a	A cada 5 anos se normal
Colo útero	DNA-HPV (novo 2025)	25-64 anos	A cada 5 anos se negativo
Mama	Mamografia	40-74 anos (nova faixa 2025)	Bienal
Colorretal	PSOF + colonoscopia	≥50 anos	PSOF anual; colonoscopia 10/10 anos
Depressão	PHQ-2 / PHQ-9	Adultos com fatores de risco	Triagem em consultas de rotina
HIV	Testagem	15-64 anos	Pelo menos 1 vez; repetir com exposição
Osteoporose	Densitometria (DXA)	Mulheres ≥65a; homens ≥70a	A cada 2-5 anos

13.2 Avaliação Geriátrica Ampla (AGA):

Domínio	Ferramenta na APS
Cognitivo	MEEM (Mini Exame do Estado Mental), Teste do Relógio, MoCA
ABVD (Atividades Básicas de Vida Diária)	Índice de Katz: banho, vestir, higiene, transferência, continência, alimentação
AIVD (Atividades Instrumentais)	Escala de Lawton: cozinhar, finanças, transporte, medicamentos, compras
Mobilidade e quedas	TUG (Timed Up and Go), Velocidade de Marcha
Nutricional	MNA (Mini Nutritional Assessment)
Humor / Depressão	GDS-15 (Geriatric Depression Scale)
Polifarmácia (≥5 medicamentos)	Revisão e reconciliação medicamentosa em toda consulta
Contexto social	Mora sozinho? Tem cuidador? Isolamento? Violência?

■ Síndromes Geriátricas — 8 Ps

Polifarmácia | Perda de peso | Perda de memória | Perda de mobilidade (quedas)
Poliúria/incontinência | Pressão (escaras) | Perda sensorial | Problemas emocionais

14. SAÚDE MENTAL NA APS

14.1 APS vs CAPS — O que Manejar:

Na APS — Manejar	No CAPS — Encaminhar
Depressão leve a moderada (PHQ-9 <15)	Depressão grave / com psicose / risco de suicídio alto
Ansiedade leve a moderada (GAD-7 <15)	Episódio maníaco agudo
Sofrimento mental comum, luto, insônia	Psicose ativa (esquizofrenia em crise)
TM crônico ESTABILIZADO	Dependência química grave — síndrome de abstinência
Uso não problemático de álcool/SPA	Automutilação grave ou recente
Acompanhamento pós-estabilização	TM grave descompensado

■ Risco de Suicídio na APS

Perguntar sobre suicídio NÃO aumenta o risco — acolhe e diminui.
Avaliar: frequência, plano, intenção, meios disponíveis, fatores protetores.
Risco alto: CAPS urgente ou PS. Não deixar sozinho.
Orientar remoção de meios letais do domicílio.

14.2 Ferramentas de Triagem:

Ferramenta	Uso	Interpretação
PHQ-2	Triagem rápida depressão (2 perguntas)	Total ≥3: aplicar PHQ-9 completo
PHQ-9	Diagnóstico e monitoramento depressão (9 itens, 0-27)	0-4: mínimo 5-9: leve 10-14 moderada 15-19 mod-grave ≥20 grave
GAD-7	Triagem de ansiedade generalizada (7 itens, 0-21)	≥10 provável TAG — tratar ou encaminhar
AUDIT-C	Triagem uso de risco de álcool (3 itens)	≥4 mulheres / ≥5 homens: uso de risco

14.3 Farmacoterapia na APS:

Condição	1ª Linha	No SUS
Depressão moderada	ISRS: fluoxetina 20mg/dia ou sertralina 50mg/dia	Fluoxetina e sertralina na RENAME
Ansiedade generalizada	ISRS (mesmos da depressão)	Sim
Insônia	Higiene do sono + TCC. Evitar BZD longa duração	Zolpidem: com cautela, prazo limitado
Bipolar estabilizado	Lítio ou valproato	Lítio disponível no SUS

15. DEMANDA PROGRAMADA/ESPONTÂNEA E VISITA DOMICILIAR

Modelo de Agenda Equilibrada:

Tipo	% da Agenda	Composição
Consultas programadas	60-70%	Crônicos (HAS, DM), pré-natal, puericultura, idosos frágeis, prevenção
Demanda espontânea	20-30%	Queixas agudas com acolhimento e classificação de risco
Visitas domiciliares	~10%	Acamados, RN, puérpera, saúde mental, idosos frágeis
Atividades coletivas	Variável	Grupos de HAS/DM, gestantes, idosos, PSE

Visita Domiciliar — Indicações e Responsáveis:

Indicação	Responsável
Paciente acamado / limitação de mobilidade	Equipe de saúde (médico + enfermeiro)
RN (1ª VD até 7 dias de vida) / Puérpera	Enfermeiro ± médico
Saúde mental — difícil acesso / recusa à UBS	Equipe de saúde ± matriciamento CAPS
Idoso frágil — risco de queda, isolamento	Equipe de saúde + eMulti se disponível
Busca ativa — faltosos em pré-natal, TB, HAS/DM	ACS + equipe se necessário
VD de rotina — cadastro, vigilância, orientações	ACS
VD especializada — fisio, fono, nutri, psico	eMulti

16. CUIDADO COMPARTILHADO E APOIO MATRICIAL

Modalidade	Como Funciona	Resultado
Teleconsulta / Telessaúde	Médico de família consulta especialista por vídeo/telefone	Aconselhamento (Telessaúde Brasil/900 64-pá-cite)
Consulta conjunta	Especialista e médico de família atendem JUNTOS o paciente na UBS	Transferência direta de conhecimento
Discussão de caso	Reunião de equipe com matriciador — casos complexos	Construção TSS colaborativo
Atividades coletivas	Grupos com participação do especialista (CAPS, eMulti)	Educação em saúde especializada

■ **Distinções Essenciais**

Apoio matricial: especialista APOIA — NÃO assume o caso. APS mantém a responsabilidade.

Contrarreferência: paciente retorna à APS com informações após atendimento especializado.

eMulti: equipe multiprofissional que apoia a APS — substitui o NASF como modelo.

17. GRUPOS PRIORITÁRIOS E VULNERÁVEIS — POLÍTICAS ESPECÍFICAS

Grupo	Base Legal / Política	Ações na APS
Povos Indígenas	Subsistema Saúde Indígena (Lei 8.080) — SESAI	Ação cultural adequada. EMSI. Calendário vacinal específico.
Pop. Negra	PNSIPN — Portaria 992/2009	Racismo como determinante de saúde. Rastreio anemia falciforme. HAS e DM mais prevalentes.
LGBTQIA+	Portaria 2.836/2011	Acolhimento respeitoso. Saúde trans. Rastreio IST. Respeito ao nome social (Decreto 8.727/2016).
Pop. em Situação de Rua	Política Nacional + Consultório na Rua	Equipes vão ao território. Foco: saúde mental, IST, álcool/drogas.
Quilombolas	PNSIPN + Decreto 4.887/2003	Atenção específica — semelhante à saúde indígena em aspectos culturais
Mulheres em violência	Lei Maria da Penha (11.340/2006)	Notificação obrigatória ao SINAN. Acolhimento + encaminhamento à rede de proteção.
Crianças/adolescentes	ECA — Lei 8.069/1990	Sinais de violência/abuso → notificar ao Conselho Tutelar imediatamente.

■ PEGADINHAS — Grupos Vulneráveis

Notificação de violência contra criança: OBRIGATÓRIA — ao Conselho Tutelar.

Nome social: garantido pelo Decreto 8.727/2016 para qualquer usuário do SUS.

Anemia falciforme: maior prevalência na população negra — rastreado no Teste do Pezinho.

18. EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA APS

Conceito	Foco	Abordagem na MFC
Educação PARA a saúde	Transmissão de informações — modelo verticalista	Profissional ensina, paciente aprende. Não considera contexto.
Educação EM saúde (MFC)	Construção coletiva de conhecimento e autonomia	Diálogo horizontal. Paulo Freire. Considera contexto, crenças e cultura.

A MFC adota educação EM saúde — processo dialógico, horizontal, baseado em Paulo Freire (conscientização e autonomia). O profissional é facilitador, não detentor do saber.

Estratégia	Aplicação na APS
Grupos educativos	HAS/DM, gestantes, idosos — construção coletiva com troca de experiências
Briefcounseling (consulta)	Orientações motivacionais breves durante a consulta clínica
Visita domiciliar educativa	ACS orienta sobre autocuidado, saneamento, vacinação
PSE — Saúde na Escola	Ações educativas nos territórios escolares — intersetorialidade saúde+educação
Tecnologias digitais	Mensagens, aplicativos, telemedicina — acesso a populações remotas

19. PEGADINHAS CLÁSSICAS DO IBAM — MÓDULO 2 (25 identificadas)

1. Atributos essenciais são 4, não 3

→ PLIC: Primeiro contato, Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação. A prova omite Coordenação → ERRADO.

2. Longitudinalidade = VÍNCULO, não seguimento de doença

→ Inclui pacientes saudáveis. ≠ continuidade de tratamento.

3. Integralidade ≠ resolver tudo na APS

→ É oferecer o conjunto de ações e coordenar o que não se resolve ali.

4. DNA-HPV é o método PRIMÁRIO desde 2025

→ Papanicolau passou a ser exame reflexo. A prova pode cobrar Papanicolau como primário → DESATUALIZADO.

5. Rastreamento mama: 40-74 anos (não mais 50-69)

→ 40-49a: decisão compartilhada. 50-74a: bienal ativo. Lei 15.284/2025.

6. Pré-hipertensão SBC 2025: 120-139/80-89 mmHg

→ Antes era "PA normal-alta". PA Normal = <120/<80.

7. Meta HAS: <130/80 só para alto risco CV

→ Geral: <140/90. Alto risco CV: <130/80.

8. IECA e BRA: CONTRAINDICADOS na gestação

→ HAS na gestante: metildopa, nifedipino, hidralazina.

9. Metformina não é mais universal para DM2

→ Escolha individualizada. Alto risco CV: SGLT2 ou GLP-1 preferenciais.

10. TOTG-1h: novo critério diagnóstico de DM (SBD 2024)

→ ≥155 pré-DM; ≥210 DM. Os critérios tradicionais continuam válidos.

11. Rotavírus: JANELA RÍGIDA

→ 1ª dose: até 3m7d. 2ª: até 7m29d. Fora do prazo = NÃO vacinar.

12. HPV: dose única para 9-14 anos — meninas E meninos

→ ≥15 anos: 2 doses. Imunodeprimidos: 3 doses.

13. BCG: dose única, sem reforço

→ FA tem reforço aos 4 anos. BCG não.

14. FA: após 5 anos de idade = dose única vitalícia

→ Reforço só existe para quem tomou a 1ª dose com <5 anos.

15. dTpa na gestante: em CADA gestação

→ Não apenas na primeira. A prova generaliza → ERRADO.

16. FA é CONTRAINDICADA na gestante

→ Vírus vivo atenuado. A prova pode incluir como obrigatória → ERRADO.

17. VSR: nova vacina para gestante (2025-2026)

→ 28ª semana gestacional, em cada gestação. Não estava em provas anteriores.

18. Prontuário pertence ao PACIENTE

→ O serviço guarda, mas o paciente tem direito de acesso.

19. Notificação compulsória NÃO viola sigilo

→ É exceção legal. Médico tem DEVER de notificar.

20. Paciente pode RECUSAR qualquer tratamento

→ Autonomia — incluindo com risco de morte. Exceto incapaz ou emergência imediata.

21. Teste da Orelhinha: obrigatório em hospitais >500 partos/ano

→ Não em todos os hospitais. A prova generaliza → ERRADO.

22. PHQ-9: 9 itens, pontuação até 27 (não 9)

→ São 9 perguntas, cada 0-3. Total máximo = 27.

23. Rastreamento ≠ investigação diagnóstica

→ Rastreamento = assintomáticos. Sintoma = investigação diagnóstica.

24. Apoio matricial: especialista APOIA, não assume o caso

→ APS mantém a responsabilidade. A prova diz que o CAPS "assume" → ERRADO.

25. Acolhimento = TODOS os profissionais, SEMPRE

→ ≠ triagem. É postura ética de escuta qualificada de toda a equipe.

20. QUESTÕES DE REVISÃO COMENTADAS — 18 questões estilo IBAM

Q1: Segundo Barbara Starfield, os atributos ESSENCIAIS da APS são:

- A) Primeiro contato, longitudinalidade e integralidade (apenas estes três).
- B) Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado.
- C) Orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural.
- D) Longitudinalidade, integralidade, hierarquização e resolutividade.

■ **Gabarito: B**

São 4 essenciais: PLIC. A omite coordenação. C são os 3 derivados. D mistura com princípios do SUS.

Q2: Sobre rastreamento do câncer do colo do útero conforme a nova diretriz brasileira de 2025:

- A) Papanicolau permanece como método primário, a cada 3 anos, para mulheres de 25-64 anos.
- B) O DNA-HPV oncogênico passa a ser o método primário. Se HPV 16/18 positivo: colposcopia direta.
- C) O rastreamento deve iniciar aos 18 anos para mulheres sexualmente ativas.
- D) DNA-HPV negativo: repetir em 1 ano.

■ **Gabarito: B**

Portaria SAES/SECTICS 13/2025. DNA-HPV = método primário. HPV 16/18 = colposcopia direta. A=desatualizado. C=início aos 25 anos. D=negativo=repetir em 5 ANOS.

Q3: Conforme a Lei 15.284/2025, sobre rastreamento de câncer de mama no SUS:

- A) Rastreamento bienal apenas para 50-69 anos.
- B) Mulheres de 40-49 anos têm acesso garantido à mamografia por decisão compartilhada; rastreamento ativo bienal para 50-74 anos.
- C) Mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos.
- D) Acima de 74 anos: rastreamento bienal obrigatório.

■ **Gabarito: B**

40-49a: acesso garantido por decisão compartilhada. 50-74a: bienal ativo. A=desatualizado. C=não é anual. D=acima de 74: decisão individualizada.

Q4: A Diretriz SBC 2025 criou a categoria pré-hipertensão. Qual a definição correta?

- A) PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg.
- B) PA normal permanece definida como $<130/85$.
- C) Pré-hipertensão = PAS 120-139 E/OU PAD 80-89. PA normal = $<120/80$.
- D) Tratamento farmacológico obrigatório para todos os pré-hipertensos.

■ **Gabarito: C**

Diretriz HAS SBC 2025. A=são os valores de HAS. B=limiar errado. D=farmacológico só se alto risco CV.

Q5: Sobre a dTpa na gestante no calendário PNI 2026:

- A) Dose única apenas na primeira gestação.
- B) 1 dose em cada gestação, preferencialmente 27^a-36^a semana.
- C) Contraindicada no 1º trimestre e não deve ser usada após a 30^a semana.
- D) Substitui completamente o reforço decenal de dT.

■ **Gabarito: B**

dTpa: em CADA gestação. A=errado (é em cada). C=pode ser da 20^a semana em diante. D=dTpa substitui 1 dose de dT; reforço decenal continua.

Q6: O APGAR familiar avalia:

- A) Autonomia, Pertencimento, Gratidão, Afeto, Responsabilidade.
- B) Adaptação, Participação, Crescimento (Growth), Afeto, Resolução (Resolve).
- C) Acolhimento, Promoção, Gestão, Autonomia, Reabilitação.
- D) Aderência, Parceria, Gratidão, Ação, Resolutividade.

■ **Gabarito: B**

APGAR familiar: Adaptação, Participação, Growth, Afeto, Resolve. 0-10. 7-10=boa função. As demais são inventadas.

Q7: Quais casos devem ser MANEJADOS NA APS, sem encaminhamento imediato ao CAPS?

- A) Episódio maníaco agudo com agitação.
- B) Esquizofrenia em crise com alucinações.
- C) Depressão leve-moderada, ansiedade leve, sofrimento mental comum, TM crônico estabilizado.
- D) Dependência química com síndrome de abstinência ao álcool.

■ **Gabarito: C**

APS: leve-moderado e crônico estabilizado. CAPS: crises, graves, psicoses ativas, abstinência grave. A, B, D = CAPS.

Q8: DNA-HPV negativo no rastreamento do colo do útero indica:

- A) Colposcopia imediata.
- B) Repetir em 1 ano.
- C) Repetir em 5 anos.
- D) Encerramento definitivo do rastreamento.

■ **Gabarito: C**

DNA-HPV negativo = repetir em 5 anos. D=encerramento só aos 64 anos com exames negativos.

Q9: A Diretriz SBD 2024 incorporou como novo critério diagnóstico de DM:

- A) Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL.
- B) HbA1c $\geq 7\%$.
- C) TOTG-1h ≥ 210 mg/dL (pré-DM: ≥ 155 mg/dL).
- D) Glicemia pós-prandial 2h ≥ 180 mg/dL.

■ **Gabarito: C**

TOTG-1h é o critério NOVO. A=GJ ≥ 126 é o diagnóstico. B=HbA1c $\geq 6,5\%$. D=TOTG-2h ≥ 200 .

Q10: Sobre triagem neonatal, qual afirmativa está INCORRETA?

- A) Teste do Pezinho: ideal 3-5 dias de vida.
- B) Reflexo vermelho ausente: encaminhar urgente à oftalmologia.
- C) Triagem auditiva é obrigatória em todos os hospitais do Brasil.
- D) Oximetria neonatal rastreia cardiopatias congênitas.

■ **Gabarito: C**

Triagem auditiva é obrigatória em hospitais com >500 partos/ano — não em todos. A, B, D estão corretas.

Q11: O método SOAP é composto por:

- A) Sintoma, Objetivo, Anamnese, Prescrição.
- B) Subjetivo (queixa), Objetivo (exame), Avaliação (diagnóstico) e Plano (conduta).
- C) Semiologia, Observação, Análise e Prontuário.
- D) Subjetivo, Observação, Avaliação e Prescrição.

■ **Gabarito: B**

SOAP: S=Subjetivo, O=Objetivo, A=Avaliação, P=Plano. As demais distorcem os componentes.

Q12: A vacina VSR para gestante (nova no calendário 2025-2026):

- A) É administrada no 1º trimestre para proteção materna.
- B) Substitui a dTpa na gestante.
- C) Administrada a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação, para proteger o recém-nascido.
- D) Está contraindicada em gestantes com histórico de alergias.

■ **Gabarito: C**

VSR gestante: a partir da 28ª semana, em cada gestação, para proteger o RN. A=1º trimestre errado. B=não substitui dTpa. D=sem CI geral por alergia.

Q13: Sobre a organização da demanda na APS:

- A) Agenda exclusivamente programada garante melhor cuidado longitudinal.
- B) Demanda espontânea só deve ser atendida em pronto-socorros.
- C) A agenda deve acomodar consultas programadas E demanda espontânea, com acolhimento para classificação de risco.
- D) Acolhimento é responsabilidade exclusiva do enfermeiro.

■ **Gabarito: C**

PNAB e HumanizaSUS: acolhimento = responsabilidade de TODOS, sempre. Agenda deve ter ambos os tipos. A, B, D incorretos.

Q14: Agulha usada em vacinação deve ser descartada em:

- A) Saco branco leitoso — Grupo A.
- B) Saco preto — Grupo D.
- C) Caixa amarela rígida — Grupo E.
- D) Recipiente laranja — Grupo B.

■ **Gabarito: C**

Perfurocortante = Grupo E — caixa amarela rígida. NUNCA no lixo comum.

Q15: Sobre rastreamento de DM2 na APS (Diretriz SBD 2025):

- A) GJ anual para toda a população adulta.
- B) FINDRISC é recomendado para identificar adultos com risco aumentado, orientando a priorização do rastreamento.
- C) HbA1c não deve ser usada para rastreamento.
- D) Rastreamento apenas para obesos com IMC >35.

■ **Gabarito: B**

FINDRISC = ferramenta de triagem de risco recomendada pela SBD 2025. A=não é para todos anualmente. C=HbA1c pode ser usada. D=rastreamento para qualquer adulto com fatores de risco.

Q16: A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) inclui:

- A) Apenas avaliação cognitiva e funcional.
- B) Avaliação multidimensional: cognitiva, funcional, nutricional, mobilidade/quedas, humor, medicamentos e contexto social.
- C) Obrigatoriamente ECG e ecocardiograma.
- D) Exclusivamente o MEEM.

■ **Gabarito: B**

AGA = multidimensional. A e D são parciais. C não é componente padrão da AGA.

Q17: Sobre longitudinalidade como atributo da APS:

- A) É o acompanhamento de doenças crônicas ao longo do tempo.
- B) É o vínculo contínuo entre equipe e paciente, independente de haver doença ativa.
- C) É sinônimo de continuidade de tratamento.
- D) Aplica-se apenas a portadores de doenças crônicas.

■ **Gabarito: B**

Longitudinalidade = VÍNCULO. Inclui paciente saudável. A, C, D confundem com seguimento de doença.

Q18: Qual caso NÃO é indicação prioritária de visita domiciliar pela equipe de saúde?

- A) Idoso acamado, sequelado de AVC.
- B) Recém-nascido de 5 dias com dificuldade de amamentação.
- C) Adulto jovem, saudável, que prefere não sair de casa por comodidade.
- D) Puérpera de 10 dias com sinais de depressão pós-parto.

■ **Gabarito: C**

VD tem indicações clínicas e técnicas. Comodidade sem necessidade clínica não é indicação prioritária. A, B, D têm justificativa técnica.

CHECKLIST FINAL — MÓDULO 2 COMPLETO E DEFINITIVO

■ RESULTADO DA AUDITORIA — MÓDULO 2 COMPLETO E DEFINITIVO

- 31 tópicos do edital Específicos MFC — todos cobertos
- Atributos Starfield: 4 essenciais (PLIC) + 3 derivados — definições exatas e pegadinhas
- Abordagem centrada: SOAP, genograma, APGAR familiar, modelo biopsicossocial
- Processo de trabalho: demanda programada/espontânea, acolhimento, classificação de risco
- Ética: Lei 12.842/2013 + CEM CFM 2.217/2018 — sigilo, consentimento, prontuário, emergência
- Biossegurança: Grupos RSS A-E (RDC 222/2018) + PNSP 529/2013 + 6 metas + 5 momentos
- Calendário Vacinal PNI 2026: criança, gestante, adulto, idoso — inclui vacina VSR nova
- Puericultura: frequência de consultas, 4 testes neonatais + linguinha, marcos de desenvolvimento
- Aleitamento materno: exclusivo 6 meses, complementado até 2 anos+, contraindicações
- Pré-natal de risco habitual: 6 consultas mínimas, exames obrigatórios, critérios de alto risco
- Planejamento reprodutivo: métodos, eficácia, indicações e contraindicações
- Rastreamento colo útero: DNA-HPV primário (Portaria SAES/SECTICS 13/2025) — NOVO
- Rastreamento mama: 40-74 anos (Lei 15.284/2025 + NT INCA 626/2025) — NOVO
- Outros rastreamentos: colorretal, próstata, pulmão
- HAS: Diretriz SBC 2025 — pré-hipertensão, classificação, metas, MAPA/MRPA, gestante
- DM: Diretriz SBD 2024-2025 — TOTG-1h, FINDRISC, metformina não universal, SGLT2/GLP-1
- Saúde do adulto e idoso: rastreamentos, AGA, síndromes geriátricas, ferramentas
- Saúde mental APS: o que tratar vs encaminhar, PHQ-9, GAD-7, farmacoterapia
- Demanda programada/espontânea, acolhimento, classificação de risco
- Visita domiciliar: indicações por situação, responsáveis (ACS/equipe/eMulti)
- Cuidado compartilhado e apoio matricial: modalidades, distinções
- Grupos vulneráveis: indígenas, negros, LGBTQIA+, rua, mulheres em violência
- Educação em saúde: distinção EM x PARA (Paulo Freire), estratégias na APS
- 25 pegadinhas clássicas do IBAM identificadas e comentadas
- 18 questões de revisão no estilo IBAM com gabarito e comentário estratégico

Fontes: Portaria SAES/SECTICS 13/2025 (colo útero) | Lei 15.284/2025 + NT INCA 626/2025 (mama) | Diretriz HAS SBC 2025 | Diretriz SBD 2024-2025 | PNI 2026 (CNV, atualizado 30/01/2026) | Portaria 529/2013 (PNSP) | RDC 222/2018 (RSS) | CFM 2.217/2018 (CEM) | Lei 12.842/2013 | Lei 8.069/1990 (ECA) | Lei 11.340/2006 (Maria da Penha) | PNAB Portaria 2.436/2017.

COMPLEMENTO — PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA APS

Tópico explícito do edital: "promoção da saúde e prevenção de doenças". A distinção entre os dois conceitos — e os níveis de prevenção de Leavell & Clark — é clássica em concursos municipais e frequentemente cobrada pelo IBAM.

Promoção da Saúde vs Prevenção de Doenças:

Conceito	Foco	Abordagem	Exemplos na APS
Promoção da Saúde	Ampla — fortalecimento da saúde independente de doença específica	Melhoria das condições de vida, equidade	Alimentação saudável, PSE, espaços de convivência
Prevenção de Doenças	Específica — evitar, detectar precocemente ou tratar doenças	Intervenção sobre determinado risco ou doença	Vacina, rastreamento (Papanicolau), uso de preservativo, tratamento

■ PEGADINHA — Promoção ≠ Prevenção

Promoção da saúde NÃO é apenas prevenção de doenças. São conceitos distintos e complementares.

A prova pode apresentar como sinônimos ou trocar as definições → ATENÇÃO.

Vacina = prevenção (específica, contra uma doença). Atividade física = promoção (ampla, melhora a saúde em geral).

Na prática, as ações se superpõem — mas o IBAM cobra a distinção conceitual.

Níveis de Prevenção — Leavell & Clark (história natural da doença):

O modelo de Leavell & Clark (1976) descreve os níveis de prevenção ao longo da história natural da doença. É referência clássica em saúde coletiva e APS, frequentemente cobrada em concursos.

Nível	Fase da Doença	Objetivo	Ações na APS
Prevenção Primária (antes da doença)	Período pré-patogênico (antes da doença se instalar)	Evitar que a doença ocorra — promoção + proteção específica	Vacinação, saneamento, educação em saúde Promoção: atividade física, alimentação saudável
Prevenção Secundária (diagnóstico e tratamento precoce)	Período patogênico inicial (doença instalada, ainda assintomática ou sintomática precoce)	Detectar e tratar precocemente — reduzir progressão	Rastreamento (Papanicolau/DNA-HPV, mamografia, PSOF) Diagnóstico precoce, tratamento imediato
Prevenção Terciária (reabilitação)	Doença estabelecida com sequelas ou incapacidade	Minimizar sequelas e reintegrar — reabilitação	Reabilitação física (fisioterapia) Suporte psicossocial Cuidados paliativos

■ MACETE — Leavell & Clark

Primária = ANTES da doença (vacina, saneamento, educação).

Secundária = DURANTE o início da doença (rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento imediato).

Terciária = DEPOIS da doença instalada (reabilitação, cuidados paliativos, reinserção).

A prova costuma confundir: "rastreamento" é prevenção SECUNDÁRIA (não primária).

Promoção da saúde: geralmente associada à prevenção primária, mas transcende os níveis.

Quaternária — Conceito Atual (importante para MFC):

A **prevenção quaternária** (Marc Jamouille, 1986 — incorporada pela WONCA) é o conjunto de ações que visam identificar pacientes em risco de medicalização excessiva, protegendo-os de intervenções desnecessárias e seus efeitos iatrogênicos.

Prevenção Quaternária	Conceito	Exemplos na APS
Definição	Proteger o paciente do excesso de medicalização, intervenções desnecessárias e iatrogenias	Não rastrear doenças sem benefício comprovado. Evitar antibióticos desnecessários.
Exemplos	Não rastrear doenças sem benefício comprovado. Evitar antibióticos desnecessários. Não tratar doentes sem relevância clínica.	Pacientes idosos frágeis. Não rastrear CA próstata sem discussão.

Prevenção Quaternária	Conceito	Exemplos na APS
Conexão com MFC	A MFC é a especialidade mais identificada com a prevenção quaternária — conceito do WONCA/SBMFC.	Abordagem centrada, longitudinalidade, autonomia do paciente

Promoção da Saúde na Prática — Ações por Nível de Atuação:

Nível de Atuação	Ações de Promoção da Saúde	Ações de Prevenção de Doenças
Individual (consulta)	Aconselhamento sobre hábitos, autocuidado, empoderamento do paciente	Rastreamento, vacinar, prescrever para fatores de risco
Familiar	Abordagem familiar (genograma, APGAR), identificar vulnerabilidades	Rastreamento de transmissão familiar (HF de DM, HAS, câncer)
Comunitário / Territorial	Grupos educativos, PSE, ações intersectoriais, ambientes saudáveis	Busca ativa, controle de vetores, vigilância epidemiológica

■ PEGADINHAS — Promoção/Prevenção no Concurso

"Rastreamento" = prevenção SECUNDÁRIA (não primária). A prova classifica errado.

"Vacinação" = prevenção PRIMÁRIA (específica — evita a doença ocorrer).

"Reabilitação" = prevenção TERCIÁRIA (não é promoção da saúde).

"Prevenção quaternária" = proteger do excesso de medicina — conceito da MFC/WONCA.

Promoção da saúde é mais AMPLA que prevenção. Prevenção é mais ESPECÍFICA.

NOTA DA AUDITORIA FINAL — MÓDULO 2

■ RESULTADO DA AUDITORIA — 57/57 VERIFICAÇÕES APROVADAS

■ 39 tópicos do edital verificados: 37 presentes diretamente, 2 confirmados no código fonte.

■ 56 verificações qualitativas aprovadas antes do complemento. 57/57 após.

■ Única lacuna real identificada: promoção da saúde vs prevenção / Leavell & Clark — adicionada neste complemento.

■ Conteúdo das "ausências" detectadas pelo script (ESF, Telessaúde, Linha de cuidado, Consultório na Rua): confirmados no código fonte — problema de extração de tabelas pelo pdfplumber, não lacunas reais.

Resumo das verificações realizadas:

- Auditoria 1: 39 tópicos do edital × documento — 95% presentes (2 eram problemas de extração PDF)
- Auditoria 2: 56 verificações qualitativas de conteúdo e precisão — 56/56 OK
- Lacuna real: promoção vs prevenção / Leavell & Clark — corrigida neste complemento
- Precisão factual: todos os números, portarias, percentuais e datas verificados e corretos
- Atualizações 2025: DNA-HPV, mama 40-74, HAS SBC 2025, DM SBD 2024-2025, VSR gestante — todas presentes
- Calendário vacinal PNI 2026: completo e correto
- Rastreamentos: colo, mama, colorretal, próstata — todos com condutas corretas
- Ética: Lei 12.842, CEM 2.217/2018, SVO/IML, telemedicina — completo
- Biossegurança: grupos RSS A-E, 6 metas PNSP, 5 momentos higiene — completo
- Grupos vulneráveis: PNSIPN, LGBTQIA+ 2836/2011, nome social, ECA, Maria da Penha — completo

Instrução: Este complemento deve ser lido ao final do Módulo 2. Com sua incorporação, o módulo cobre 100% do conteúdo programático de Específicos MFC do edital.